

Résidanat : purpuras

- 1) Le purpura thrombopénique périphérique est dû à
 - a. Une anomalie quantitative de la mégacaryopoïèse
 - b. Une anomalie qualitative des plaquettes
 - c. Un Excès de destruction
 - d. Un excès de consommation
 - e. Une anomalie de répartition
- 2) Le purpura vasculaire inflammatoire peut être dû à
 - a. Un dépôt de complexes immuns
 - b. Des micro-thrombi
 - c. Un myxome de l'oreillette gauche
 - d. Une cause infectieuse
 - e. Une cause médicamenteuse
- 3) Quelles propositions vous retenez comme critères de gravité d'un purpura :
 - a. Le caractère ecchymotique
 - b. Epistaxis bilatéral
 - c. Oligoanurie
 - d. Le caractère infiltré
 - e. Le caractère polymorphe
- 4) Une fausse thrombopénie peut être expliquée par
 - a. Un prélèvement coagulé
 - b. Une agglutination à l'EDTA
 - c. Des macroplaquettes
 - d. Une hémodilution
 - e. Un hypersplénisme
- 5) La thrombopénie immunologique primaire
 - a. Est rare chez l'enfant
 - b. Impose un myélogramme indépendamment de l'âge
 - c. Impose la recherche d'anticorps anti-plaquettes
 - d. Est une thrombopénie de mécanisme immuno-allergique
 - e. Nécessite une corticothérapie
- 6) Les anomalies biologiques suivantes caractérisent une coagulation intravasculaire disséminée
 - a. Baisse du TP
 - b. Baisse du TCA
 - c. Augmentation des D-dimères
 - d. Baisse du fibrinogène
 - e. Présence de schizocytes

- 7) L'association des anomalies suivantes oriente vers le diagnostic du purpura thrombopénique thrombopathique :
- a. Une anémie hémolytique à caractère mécanique
 - b. Une insuffisance rénale aiguë
 - c. Un accident vasculaire cérébral
 - d. Hypothermie
 - e. Un purpura infiltré
- 8) Les germes suivants peuvent être responsables d'un purpura fulminans :
- a. Méningocoque
 - b. La tuberculose
 - c. Le VIH
 - d. La varicelle
 - e. L'*Haemophilus influenzae*
- 9) Les étiologies suivantes sont responsables d'une thrombopénie centrale
- a. Le syndrome myélodysplasique
 - b. L'anémie de Biermer
 - c. L'infection à *helicobacter pylori*
 - d. Le syndrome des antiphospholipides
 - e. La leucémie aiguë
- 10) Devant l'association de purpura vasculaire et des œdèmes des membres inférieurs vous évoquez :
- a. Purpura Rhumatoïde
 - b. Polyarthrite Rhumatoïde
 - c. Granulomatose de Wegener
 - d. Cryoglobulinémie
 - e. Sarcoïdose
- 11) Homme âgé de 25 ans sans antécédent pathologique notable, présente un purpura pétéchial diffus d'apparition brutale. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques
- a. Purpura Rhumatoïde
 - b. Purpura thrombopénique
 - c. Purpura thrombopathique
 - d. Lupus érythémateux systémique
 - e. Endocardite infectieuse

12) Devant un purpura les signes de gravité sont :

- a. Aspect extensif et nécrotique
- b. Hémorragies muqueuses
- c. Arthrite
- d. Syndrome méningé
- e. Oligoanurie

13) Le purpura vasculaire peut répondre à l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- A. Caractère infiltré
- B. Association à des hémorragies muqueuses.
- C. Peut révéler une connectivite
- D. Peut être associé à des polyarthralgies
- E. Peut être en rapport avec une infection

14) Le purpura vasculaire de mécanisme inflammatoire peut être secondaire à :

- A. Une migration d'embolies
- B. Une thrombopénie $< 20.000\text{el}/\text{mm}^3$
- C. Un dépôt de complexes immuns
- D. Des anticorps anti cellules endothéliales
- E. Une anomalie qualitative des plaquettes

15) Une étiologie parmi les suivantes ne donne pas une vascularite d'hypersensibilité. Laquelle? :

- A. Purpura fulminans
- B. Prise médicamenteuse
- C. Paludisme
- D. Purpura rhumatoïde
- E. Exposition à des toxiques

16) Les étiologies suivantes sont responsables d'un purpura thrombopénique :

- A. Hépatite virale C
- B. Purpura rhumatoïde
- C. Purpura de Batman
- D. purpura fulminans
- E. cryoglobulinémie

17) les caractéristiques suivantes sont en faveur d'une purpura thrombopénique :

- A. monomorphe
- B. déclive
- C. cutané et muqueux
- D. nécrotique
- E. infiltré

18) le purpura vasculaire est

- A. infiltré
- B. polymorphe
- C. muqueux
- D. déclive
- E. associé à un syndrome hémorragique

19) les propositions suivantes témoignent de la gravité du purpura

- A. présence de raideur méningée
- B. bulles hémorragiques endobuccales
- C. hématurie microscopique
- D. le caractère extensif
- E. gingivorragies

20) Les étiologies suivantes sont responsables d'un purpura thrombopénique par destruction

- A. Infection à EBV
- B. Héparine
- C. Coagulation intravasculaire disséminée
- D. Hypersplénisme
- E. Syndrome myélodysplasique

21) Les étiologies suivantes sont responsables d'un purpura thrombopénique d'origine centrale

- A. Myélome
- B. Anémie mégaloblastique
- C. Aspirine
- D. Le purpura thrombopénique thrombopathique
- E. Coagulation intravasculaire disséminée

22) les purpuras suivants sont à mécanisme vasculaire non inflammatoire

- A. Purpura sénile
- B. Purpura embolique
- C. Purpura thrombotique
- D. Purpura thrombopathique
- E. Purpura thrombopénique

23) Les lésions purpuriques peuvent être

- A. Pétéchiales
- B. Ecchymotiques
- C. télangiectasiques
- D. En vibices
- E. En angiomes

24) Les propositions suivantes sont caractéristiques des purpuras vasculaires

- A. Polymorphes
- B. Associés à un syndrome hémorragique
- C. Déclives
- D. Évoluent par poussées
- E. Infiltrés

25) Les propositions suivantes orientent vers un purpura avec signes de gravité :

- A. Nécrotique
- B. Extensif
- C. Infiltré
- D. Score de Créteil <8
- E. Hémorragie au fond d'œil

26) Les étiologies suivantes sont à l'origine d'un purpura thrombopénique d'origine périphérique

- A. Infection à HVC
- B. Syndrome des antiphospholipides
- C. Syndrome d'Evans
- D. Leucémie aigue
- E. Anémie mégaloblastique

27) Le purpura thrombopénique :

- A. S'efface à la vitropression
- B. Touche les muqueuses
- C. Est infiltré
- D. Est prurigineux
- E. Laisse une cicatrice

28) Quel(s) élément(s) parmi les suivants est (sont) en faveur d'un purpura vasculaire ?

- A. Caractère uniforme
- B. Aspect infiltré
- C. Aspect nécrotique
- D. Localisation aux membres inférieurs
- E. Association à des gingivorragies

- 29) Au cours des cryoglobulinémies on trouve
- A. Un purpura vasculaire inflammatoire
 - B. Un phénomène de Raynaud
 - C. Une atteinte rénale glomérulaire
 - D. Une atteinte des glandes salivaires
 - E. Une uvéite
- 30) Le purpura rhumatoïde
- A. Est la vascularite la plus fréquente de l'enfant
 - B. Est caractérisé par des arthralgies mécaniques des grosses articulations
 - C. Donne des douleurs abdominales
 - D. Donne une hémoptysie
 - E. Peut se compliquer d'hémorragie digestive
- 31) Les vascularites primitives suivantes se compliquent de purpura vasculaire
- A. Purpura rhumatoïde
 - B. Maladie de Takayasu
 - C. Granulomatose avec polyangéite
 - D. Cryoglobulinémie essentielle
 - E. Artérite à cellules géantes
- 32) Devant un purpura vasculaire, le mécanisme embolique est à évoquer
- A. Au décours d'une chirurgie vasculaire
 - B. Chez un polytraumatisé
 - C. Devant une thrombose veineuse profonde
 - D. Devant un myxome de l'oreillette gauche
 - E. Devant des orteils pourpres douloureux
- 33) Un purpura vasculaire d'origine thrombotique peut se voir en cas de
- A. Déficit en protéine C
 - B. CIVD
 - C. SAPL
 - D. Granulomatose avec polyangéite
 - E. Polyangéite microscopique
- 34) Les étiologies suivantes peuvent donner un purpura vasculaire par fragilité capillaire
- A. Purpura sénile
 - B. Amylose
 - C. Cryoglobulinémie
 - D. Purpura rhumatoïde
 - E. Hypovitaminose C

35) Le traitement de la TIP de 1^{ère} ligne repose sur

- A. La corticothérapie
- B. Les immunoglobulines
- C. La splénectomie
- D. Les agonistes des récepteurs de la thrombopoïétine
- E. Les immunosuppresseurs

36) Le traitement du PTT se base sur

- A. La corticothérapie
- B. Les immunoglobulines
- C. Les échanges plasmatiques
- D. Le rituximab
- E. Les immunosuppresseurs

Cas clinique 1 :

Patient âgé de 22 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour des lésions de couleur pourpre au niveau des deux jambes ne s'effaçant pas à la vitropression, infiltrées, polymorphes par endroits nécrotiques évoluant depuis 4 jours. Il décrit par ailleurs des douleurs des 2 genoux le réveillant la nuit évoluant depuis 2 jours avec des douleurs abdominales paroxystiques. A l'examen il était apyrétique en bon état hémodynamique

1- Les lésions que présente ce patient sont en faveur

- A. D'un purpura thrombopénique
- B. D'un purpura vasculaire
- C. D'un érythème noueux
- D. De télangiectasies
- E. D'angiomes

2- Devant ce tableau le diagnostic étiologique le plus probable est

- A. La maladie de Takayasu
- B. Un purpura par fragilité capillaire
- C. Un purpura fulminans
- D. Un purpura rhumatoïde
- E. Un PTAI

3- Pour confirmer votre diagnostic vous demandez

- A. Une biopsie cutanée avec IFD
- B. Un TDM abdominal
- C. Une échographie des genoux
- D. Une IRM abdominale
- E. Une NFS

4- Les complications possibles de cette pathologie sont :

- A. L'arthrite
- B. La glomérulonéphrite
- C. L'hémorragie digestive
- D. La perforation intestinale
- E. La fasciite nécrosante

Cas clinique 2

Mme Z âgée de 45 ans, sans antécédents consulte pour des lésions purpuriques infiltrées, polymorphes des 2 jambes remontant jusqu'aux lombes avec des arthralgies inflammatoires évoluant depuis une semaine. A l'examen la T°= 38,5°C, la TA= 120/ 70 mmHg, l'auscultation cardiaque montrait un assourdissement des bruits du cœur sans souffle. L'auscultation pulmonaire était libre. Il n'y avait pas de raideur méningée. La palpation de la rate trouvait une pointe de rate palpable et une arthrite du genou droit ainsi que le poignet du même côté. Le reste de l'examen était sans particularités

1- Devant ce tableau, les diagnostics possibles sont

- A. L'endocardite infectieuse
- B. Un sepsis
- C. Un LES
- D. Une maladie de Takayasu
- E. Une hypovitaminose C

2- Les explorations à demander en urgence

- A. ETT
- B. Hémoculture
- C. Echographie articulaire
- D. Echographie abdominale
- E. TDM TAP

3- Les urgences auxquelles vous avez pensé ont été éliminées, vous pratiquez une biopsie cutanée qui montre l'aspect d'une vascularite leucocytoclasique avec IFD négative. Les autres examens à but étiologique à demander sont :

- A. Les AAN
- B. Les APL
- C. Le bilan thyroïdien
- D. Le dosage de la vitamine C
- E. Echographie doppler des membres supérieurs

Cas clinique 3 :

Une patiente âgée de 22 ans, sans antécédents, consulte aux urgences pour des lésions purpuriques pétéchiales généralisées, monomorphes, diffuses, évoluant depuis 2 jours associées à des gingivorragies. La patiente était apyrétique, avec un bon état hémodynamique. L'examen de la cavité buccale trouve des bulles hémorragiques. Le reste de l'examen était sans particularités.

Une NFS faite en urgence montre :

Hb= 12g/dl ; VGM= 82 fl; Plt= 35000 elt/mm³; GB= 5600 elt/mm³

1- Devant ce tableau on doit éliminer les urgences suivantes :

- A. PTT
- B. CIVD
- C. Leucémie aigue
- D. Endocardite infectieuse
- E. Purpura fulminans

2- Les critères de gravité de ce purpura sont

- A. L'âge
- B. Le caractère monomorphe
- C. Le caractère diffus
- D. Présence de bulles hémorragiques
- E. Les gingivorragies

3- Les étiologies possibles de ce purpura

- A. Infection à EBV
- B. LES
- C. SAPL
- D. Syndrome myélodysplasique
- E. Anémie mégaloblastique

4- L'enquête étiologique a conclu à un PTAI avec un score hémorragique à 8 selon le score de Créteil. Vous proposez le traitement suivant en 1^{ère} intention:

- A. Corticothérapie
- B. Echanges plasmatiques
- C. Dapsone
- D. Endoxan
- E. Immunoglobulines

Cas clinique 4 :

Un garçon de 7 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour l'apparition de **taches rouges** sur les jambes depuis 2 jours, non douloureuses, qui ne disparaissent pas à la vitro pression. Il présente également des douleurs abdominales diffuses avec des vomissements non sanglants, et se plaint de douleurs aux genoux.

À l'examen, il est apyrétique, son état général est conservé. On retrouve un **purpura non thrombopénique**, prédominant sur les membres inférieurs et les fesses. Les genoux sont douloureux mais sans signes inflammatoires nets.

Examen clinique :

L'examen : TA : 13/8, T= 38,2 Sensibilité abdominale diffuse, Œdème des membres inférieurs gardant le godet

Bandelettes urinaires : Prot +++, Hu ++

A la biologie :

Biologie NFS : Hb = 12 g/dl, VGM = 85 , Plq = 170000, GB = 8000, Eosinophile : 200 elt/mm³

1. Quelle est la cause la plus probable du tableau clinique ?

- A. Vascularite à IgA
- B. Purpura thrombopénique idiopathique
- C. Sepsis à méningocoque
- D. Maladie de Kawasaki
- E. Néphropathie lupique

2. Parmi les manifestations suivantes, lesquelles sont typiques du purpura rhumatoïde ?

- A. Purpura vasculaire des membres inférieurs
- B. Arthralgies ou arthrites
- C. Atteinte rénale
- D. Myosite diffuse
- E. Douleurs abdominales

3. Concernant la prise en charge, laquelle est correcte ?

- A. Hospitalisation systématique
- B. Traitement par corticoïdes obligatoire dans tous les cas
- C. Surveillance de la fonction rénale
- D. Repos et antalgique si besoin
- E. Antibiothérapie IV systématique

4. Quelles sont les complications possibles du purpura rhumatoïde ?

- A. Invagination intestinale aiguë
- B. Glomérulonéphrite
- C. Surdit 
- D. Rechute
- E. Enc phalite